



สถานะ สุขภาพ ประชาชน

ศูนย์บริการสาธารณสุข
บ้านโทกหัวช้าง

สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
จังหวัดลำปาง

ปีงบประมาณ 2568

3 GOOO HEALTH
AND WELL-BEING



สารบัญ

ข้อมูลสุขภาพหน้า 1-13

1. ข้อมูลทั่วไปตำบลพระบาท

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต	หน้า 1
1.2 ลักษณะภูมิศาสตร์	หน้า 1
1.3 การปกครอง	หน้า 2
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ	หน้า 2
1.5 ด้านสาธารณสุขและเครือข่ายบริการ	หน้า 2

2. ลักษณะองค์กร ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง

2.1 ประวัติความเป็นมา	หน้า 2
2.2 ข้อมูลการนำองค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์)	หน้า 3
2.3 ข้อมูลประชากรและโครงสร้างประชากร	หน้า 3-5
▪ ตารางข้อมูลประชากรรายหมู่บ้าน	หน้า 3
▪ ตารางโครงสร้างประชากรจำแนกเพศและอายุ	หน้า 4
▪ พีรามิดประชากร	หน้า 5
▪ ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข	หน้า 5
2.4 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข	หน้า 6
▪ ตารางบุคลากรสาธารณสุข	หน้า 6
▪ อัตราส่วนบุคลากรต่อประชากรเป้าหมาย	หน้า 6
2.5 ข้อมูลสาธารณสุขมูลฐาน	หน้า 7
▪ ข้อมูลอสม. ต่อหลังคาเรือน	หน้า 7

▪ ข้อมูลประชากรตามสถิติหลักประกันสุขภาพ	หน้า 7
2.6 ข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุข	หน้า 8
▪ ตารางให้บริการรายวัน	หน้า 8
▪ สถิติผู้มารับบริการ OP-PP ปี 2564-2568	หน้า 8-9
▪ กราฟแนวโน้มผู้มารับบริการ	หน้า 9
3. สถิติชีพและข้อมูลสุขภาพ	
3.1 อัตราเกิด-ตาย และอัตราเพิ่มประชากร	หน้า 9-10
▪ ตารางอัตราเกิด-ตาย ปี 2564-2568	หน้า 9
▪ กราฟอัตราเพิ่มประชากร	หน้า 9
3.2 สาเหตุการเสียชีวิต 10 ลำดับ ปี 2566-2568	หน้า 10
3.3 10 อันดับโรคของผู้ป่วยนอก ปี 2568	หน้า 11
3.4 โรคติดต่อสำคัญทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2568	หน้า 12
3.5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 10 อันดับ ปี 2568	หน้า 13

ภาคผนวก

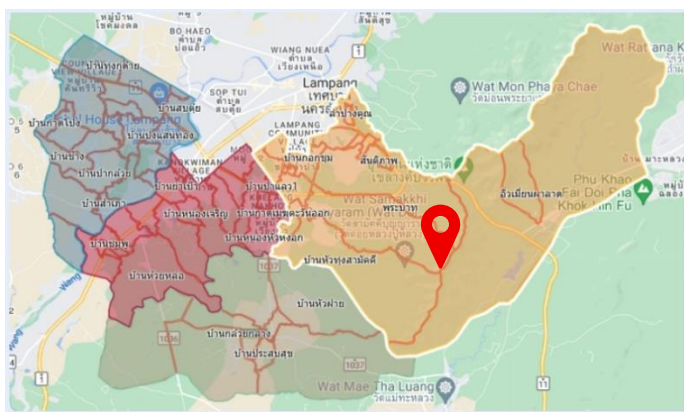
- แผนที่เขตรับผิดชอบ ศบส.บ้านโทกหัวช้าง
- ภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการบริการเชิงรุก
- สรุปผลการดำเนินงานตามกลุ่มวัย

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง

ศูนย์บริการสาธารณสุข
บ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1. ข้อมูลทั่วไป ตำบลพระบาท



รูปภาพ 1 จุดสีแดงแผนที่ตำบลพระบาทและเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศบส.บ้านโทกหัวช้าง

1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต

ตำบลพระบาท ในเขตของอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ ประมาณ 88.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 553.06 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาล นครลำปาง และตำบลพิชัย ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลชมพูและเขตอำเภอแม่ทะ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลพิชัยและอำเภอแม่เมาะ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลชมพูและเทศบาลนครลำปาง

1.2 ลักษณะภูมิศาสตร์

พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ โดยมีลักษณะเป็นที่ราบ ที่ราบลุ่ม และบริเวณที่เป็นเนินเขา ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นป่าและส่วนที่เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท

1.3 การปกครอง

ตำบลพระบาทมีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 8 หมู่บ้าน 16 ชุมชน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในระดับชุมชนมีประธานชุมชนเป็นผู้นำร่วมกับคณะกรรมการชุมชน

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ

มีสภาพเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นลักษณะชุมชนเมืองและชนบททำให้การประกอบอาชีพ ทั้งค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ ลูกจ้างและทำเกษตรกรรม อาทิ เลี้ยงสัตว์ ทำไร่

1.5 ด้านสาธารณสุข

ตำบลพระบาทมีสถานบริการสุขภาพและเครือข่าย ประกอบด้วย

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง 1 แห่ง
2. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 261 คน

2. ลักษณะองค์กร ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง

2.1 ประวัติ

ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง เดิมเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณสุขให้ท้องถิ่นดูแล เมื่อ 1 ธันวาคม 2564 สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีอาคาร 2 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 งบประมาณ 1,950,000 บาท

ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง และ โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งเป็นแม่ข่าย ประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 10 นาที ประชาชนเดินทางสะดวก โดยใช้ถนน วชิราวุธดำเนิน , ถนน สายลำปางแม่ทะ, และถนนสายหลักลำปาง-แม่เมาะ โดยมีหมู่บ้านรับผิดชอบจำนวน 8 หมู่บ้าน 16 ชุมชน

2.2 ข้อมูลการนำองค์กร

- | | |
|------------|---|
| วิสัยทัศน์ | โปร่งใส กระชับ ฉับไว ใส่ใจบริการ เปี่ยมด้วยมาตรฐานวิชาชีพ |
| พันธกิจ | <ol style="list-style-type: none">1. จัดบริการสุขภาพ ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพสถานบริการด้านสาธารณสุข2. พัฒนาระบบสุขภาพโดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยบริการเชิงรับและบริการเชิงรุก แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย3. บริหารงานสาธารณสุขด้วยหลักธรรมาภิบาลและจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน |

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

1. ระบบบริการสุขภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ภาครัฐเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการจัดการระบบสุขภาพดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ประชาชน มีสุขภาพดี มีความสุข พึงพอใจ ระบบบริการ
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาภาครัฐเครือข่ายให้มีส่วนร่วมดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย
3. บริหารจัดการสาธารณสุขด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)

โปร่งใส กระชับ ฉับไว ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

2.3 ข้อมูลประชากร

ตาราง 1 ข้อมูลประชากรจำแนกรายหมู่บ้านเปรียบเทียบกับ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2568 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร (คน)		
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1	ป่าขาม	1347	1359	1341
2	บุญเกิด	3239	3108	3180
3	โทกหัวช้าง	1724	1689	1717
4	ผาลาด	1204	1207	1208
5	หนองปล้อง	964	945	966
6	กอกชุม	2016	1994	2009
7	หนองห้า	1699	1713	1712
8	หัวทุ่งสามัคคี	1135	1091	1110
รวม		13,328	13,106	13,243

ที่มา: รายงานประชากรสัณฐานวิทยาไทย สำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย จาก HDC ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2568

จากตารางข้อมูลประชากรจำแนกรายหมู่บ้านเปรียบเทียบกับ ปี ตั้งแต่ปี 2566-2568 พบว่า จำนวนประชากรรวมมีแนวโน้ม คงที่และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 13,238 คนในปี 2566 เป็น 13,243 คนในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04%แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของจำนวนประชากรในพื้นที่เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านพบว่าหมู่ที่ 2 บ้านบุญเกิด มีประชากรมากที่สุด จำนวน 3,180 คนในปี 2568หมู่ที่ 5 บ้านหนองปล้อง มีประชากรน้อยที่สุด จำนวน 966 คนในปี 2568 ขณะที่หมู่บ้านอื่น ๆ มีจำนวนประชากรเฉลี่ยระหว่าง 1,100 ถึง 2,000 คน โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

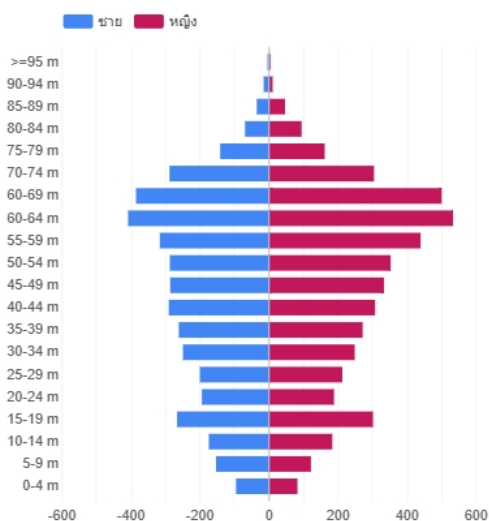
ตาราง 2 โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ เปรียบเทียบเป้าหมายประชากรสำรวจ ปี 2568

กลุ่มอายุ	เป้าหมายประชากร					
	ประชากรรวม		ชาย		หญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แรกเกิด-04	187	2.07	99	1.09	88	0.97
05-09	294	3.25	161	1.78	133	1.47
10-14	425	4.70	206	2.28	219	2.42
15-19	657	7.26	311	3.44	346	3.82
20-24	392	4.33	195	2.15	197	2.18
25-29	410	4.53	194	2.14	216	2.39
30-34	510	5.64	252	2.78	258	2.85
35-39	533	5.89	265	2.93	268	2.96
40-44	602	6.65	287	3.17	315	3.48
45-49	622	6.87	283	3.13	339	3.75
50-54	636	7.03	288	3.18	348	3.85
55-59	753	8.32	316	3.49	437	4.83
60-64	946	10.45	411	4.54	535	5.91
65-69	895	9.89	391	4.32	504	5.57
70-74	600	6.63	288	3.18	312	3.45
75-79	306	3.38	141	1.56	165	1.82
มากกว่า 80	281	3.11	118	1.30	163	1.80
รวม	9,049	100.00	4,206	46.48	4,843	53.52

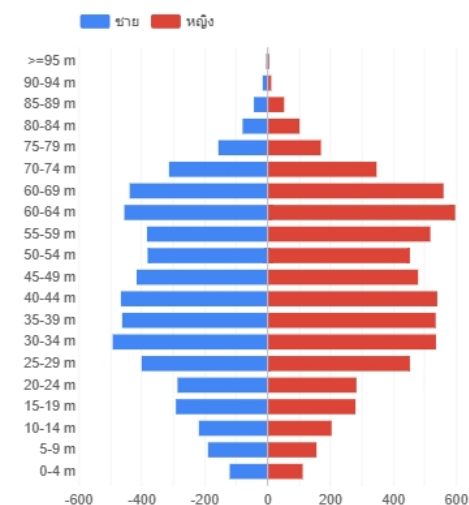
ที่มา: รายงานประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุ ปี 2568 (Type 1+3) จาก JHCIS ณ วันที่ 7 ต.ค.2568

จากตารางที่ 2 โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุจำแนกเพศ ซึ่งประชากรสำรวจอยู่อาศัยจริง ปี 2568 จากข้อมูลประชากรรวมทั้งสิ้น 9,049 คน พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.52) โครงสร้างประชากรส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.1 ขณะที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีเพียงร้อยละ 10.02 สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งส่งผลให้การวางแผนด้านสาธารณสุขควรมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการป้องกันโรคเรื้อรังในวัยแรงงานเป็นสำคัญ

ปิรามิดประชากรสำรวจ



ปิรามิดประชากรทะเบียนราษฎร์



รูปภาพ 2 แสดงปิรามิดประชากร ข้อมูลจาก HDC และ JHCIS ณ วันที่ 7 ต.ค.2568

จากรูปภาพ 2 แสดงปิรามิดประชากร จากการเปรียบเทียบปิรามิดประชากรจากทะเบียนราษฎร์และข้อมูลสำรวจ พบว่าโครงสร้างประชากรของพื้นที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก โดยกลุ่มอายุ 50-69 ปีเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด สะท้อนถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพศหญิงมีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะในช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ขณะที่จำนวนเด็กวัยแรกเกิดถึง 14 ปีมีแนวโน้มลดลง แสดงถึงอัตราการเกิดที่ลดลงและแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านทางประชากรอย่างชัดเจน ซึ่งข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริการสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับโครงสร้างประชากรของพื้นที่

ตาราง 3 แสดงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องบริการของ ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ปี 2568

ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน	ข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด	4,287 หลัง	ผู้สูงอายุติดสังคม	2,786 คน
ประชากรสำรวจ	9,049 คน	ผู้สูงอายุติดบ้าน	39 คน
ชาย	4,206 คน	ผู้สูงอายุติดเตียง	48 คน
หญิง	4,843 คน	กลุ่มดูแลระยะยาว (LTC)	8 คน
เด็กแรกเกิด – น้อยกว่า 1 ปี	43 คน	โรงเรียน	2 แห่ง
กลุ่มอายุ 1 – น้อยกว่า 5 ปี	144 คน	นักเรียน	592 คน
กลุ่มอายุ 5 – น้อยกว่า 20 ปี	1,376 คน	ศูนย์พัฒนาการเด็ก	3 แห่ง
หญิงวัยเจริญพันธุ์ 15-49	1,939 คน	ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุเอกชน	1 แห่ง
กลุ่มอายุ 35-59 ปี	3,146 คน	คลินิกเอกชน	1 แห่ง
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ขึ้นไป	3,028 คน	ร้านขายของชำ	43 ร้าน
คนพิการ (สิทธิคนพิการ)	171 คน	อสม.	261 คน

ที่มา: รายงานสำรวจข้อมูลสุขภาพของประชากรในพื้นที่ ปี 2568

2.4 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา
1	นางจารุณี ปันดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2	นายพิเชษฐ์ชัย วิลลา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
3	นายอภิวัฒน์ มีทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
4	น.ส.สุวรรณี ใจกันติ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ปวส.สาขาบัญชี
5	น.ส.พรพิมล ธรรมสอน	เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล	บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
6	นายวิสารัตน์ จันทรตา	นักวิชาการสาธารณสุข	สาธารณสุขศาสตร (อนามัยชุมชน)
7	นางเกศราพร จันทรสม	พยาบาลวิชาชีพ	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
8	นางสาวเบญจพร จอมมล	นักวิชาการสาธารณสุข	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม
9	น.ส.ชาลิสา เตชะวงศ์	พนักงานบริการ	มัธยมศึกษาตอนปลาย
10	น.ส.พรณิชา วงศ์บุตร	พนักงานบริการ	มัธยมศึกษาตอนปลาย
11	นางปณณนุช ตุ่นวัน	พนักงานบริการ	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
12	นางเพ็ญนภา วงศ์หาญ	พนักงานบริการ	มัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่มา: ทะเบียนบุคคล ศบส.บ้านโทกหัวช้าง ณ วันที่ 7 ต.ค. 2568

ตาราง 5 แสดงจำนวนและอัตราส่วนบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากรเป้าหมาย

ประเภทวิชาชีพ	เป้าหมาย	จำนวน (คน)	อัตราส่วน
พยาบาลวิชาชีพ	1:2,500	3	1: 3,016
นักวิชาการสาธารณสุข	1:1,250	3	1: 3,016

ที่มา: ข้อมูลประชากรจากระบบ JHCIS ณ วันที่ 7 ต.ค. 2568

จากตาราง 5 แสดงจำนวนและอัตราส่วนบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากรเป้าหมาย ของประชากรที่อาศัยจริงในพื้นที่พบว่าจำนวนอัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขยังไม่พอเพียงตามอัตราส่วนเป้าหมาย

2.5 ข้อมูลด้านสาธารณสุขมูลฐาน

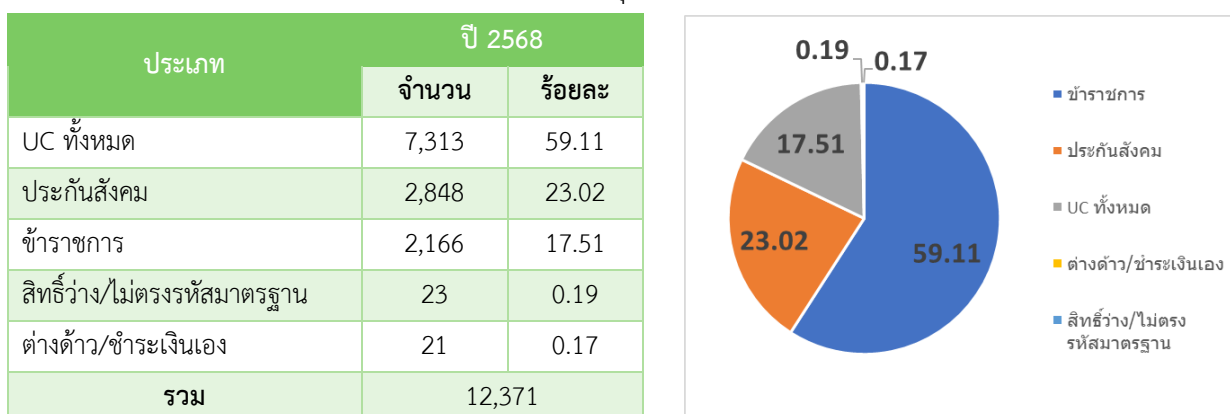
ตาราง 6 แสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต่อเขตรับผิดชอบหลังคาเรือน

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนหลังคาเรือน	จำนวน อสม.	อัตราส่วนรับผิดชอบ
1	ป่าขาม	483	22	1:22
2	บุญเกิด	1105	57	1:19
3	โทกหัวช้าง	520	35	1:15
4	ผาลาด	331	30	1:11
5	หนองปล้อง	344	18	1:19
6	กอกชุม	585	35	1:17
7	หนองห้า	540	35	1:15
8	หัวทุ่งสามัคคี	379	29	1:13

ที่มา: จำนวน อสม. จากทะเบียน อสม. ศบส.บ้านโทกหัวช้าง ณ วันที่ 7 ต.ค. 2568

จากตาราง 6 แสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต่อเขตรับผิดชอบหลังคาเรือน มีจำนวน อสม.ทั้งหมดมี 261 คน โดยหมู่บ้านที่มี อสม. มากที่สุดคือ บ้านบุญเกิด จำนวน 57 คน หมู่บ้านที่มีอสม. น้อยที่สุดคือ บ้านหนองปล้อง จำนวน 18 คน หากเทียบอัตราส่วนต่อ อสม.ดูแลหลังคาเรือนตามเกณฑ์ อสม. 1 คน ต่อ หลังคาเรือน พบว่า หมู่บ้านที่มี อสม.ดูแลหลังคาเรือนตามยังไม่ตามเกณฑ์ทั้งหมด เนื่องจากมีการพิจารณา พื้นที่ชนบทและชานเมือง: โดยทั่วไป อสม. 1 คน ดูแล 8-15 ครัวเรือน พื้นที่เขตชุมชนหนาแน่น: สำหรับชุมชนแออัด อาจปรับเกณฑ์เป็น 1 คน ต่อ 20-30 ครัวเรือน

ตาราง 7 จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพและกราฟแสดงสัดส่วนตามสิทธิ ปี 2568



ที่มา: รายงานความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพโดยรัฐ จากJHCIS ณ วันที่ 7 ต.ค. 2568

จากตาราง 7 จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปี 2568 โดยคิดจากประชากรในทะเบียนฐานข้อมูล จากมากไปหาน้อย พบว่าปี 2568 (1)สิทธิประเภท UC ทั้งหมด ร้อยละ 59.11 (2)สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 23.02 (3)สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.51 (4)สิทธิว่างหรือไม่ตรงรหัสมาตรฐาน ร้อยละ 0.19 (5)สิทธิต่างด้าว/ชำระเงินเอง ร้อยละ 0.17

2.6 ข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุข

ลักษณะหน่วยบริการ ให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น และฟื้นฟูสภาพ โดยให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตาราง 8 แสดงตารางให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง

วัน	เช้า (8.30-12.00)	บ่าย(13.00-16.30)
จันทร์	ตรวจรักษาโรคทั่วไป	ตรวจรักษาโรคทั่วไป , เยี่ยมบ้าน
อังคาร	ตรวจรักษาโรคทั่วไป , คลินิก NCD	ตรวจรักษาโรคทั่วไป , เยี่ยมบ้าน
พุธ	ตรวจรักษาโรคทั่วไป,วัคซีนเด็ก (สัปดาห์ที่ 2), ตรวจพัฒนาการเด็ก เจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปี (สัปดาห์ที่ 1 และ 4)	ตรวจรักษาโรคทั่วไป , เยี่ยมบ้าน
พฤหัสบดี	ตรวจรักษาโรคทั่วไป, คลินิก NCD, วางแผนครอบครัว	ตรวจรักษาโรคทั่วไป , เยี่ยมบ้าน
ศุกร์	ตรวจรักษาโรคทั่วไป , คลินิก NCD และจิตเวช	ตรวจรักษาโรคทั่วไป , อนามัยโรงเรียน

ตาราง 9 แสดงจำนวนผู้มารับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ปี 2564-2568

ปีงบประมาณ	จำนวนคน	จำนวนครั้ง	OP	ร้อยละ OP	PP	ร้อยละ PP
ปี 2564	5,153	12,832	6,410	49.95	6,686	50.05
ปี 2565	2,787	8,774	5,907	67.32	2,564	32.68
ปี 2566	3,328	10,348	6,423	62.07	3,456	37.93
ปี 2567	4,026	11,485	6,283	54.71	4,984	45.29
ปี 2568	7,830	20,120	7,165	35.61	12,965	64.39

ที่มา: ฐานข้อมูล JHCIS ศบส.บ้านโทกหัวช้าง ณ วันที่ 30 ก.ย.68



จากตาราง 9 ศูนย์บริการมีแนวโน้ม ขยายบริการครอบคลุมประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2568สัดส่วนบริการ PP (ส่งเสริมป้องกัน) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีล่าสุด จากเพียง 32.68% ในปี 2565 เป็น 64.39% ในปี 2568 สะท้อนทิศทางการดำเนินงานที่เน้น การป้องกันก่อนการรักษา (Preventive & Promotive Health Services) แนวโน้มนี้สอดคล้องกับนโยบาย “สุขภาพดีเริ่มต้นที่ชุมชน” และการสร้างเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. สถิติชีพและข้อมูลสุขภาพ

3.1 อัตราเกิด-ตายและร้อยละการเพิ่มประชากร

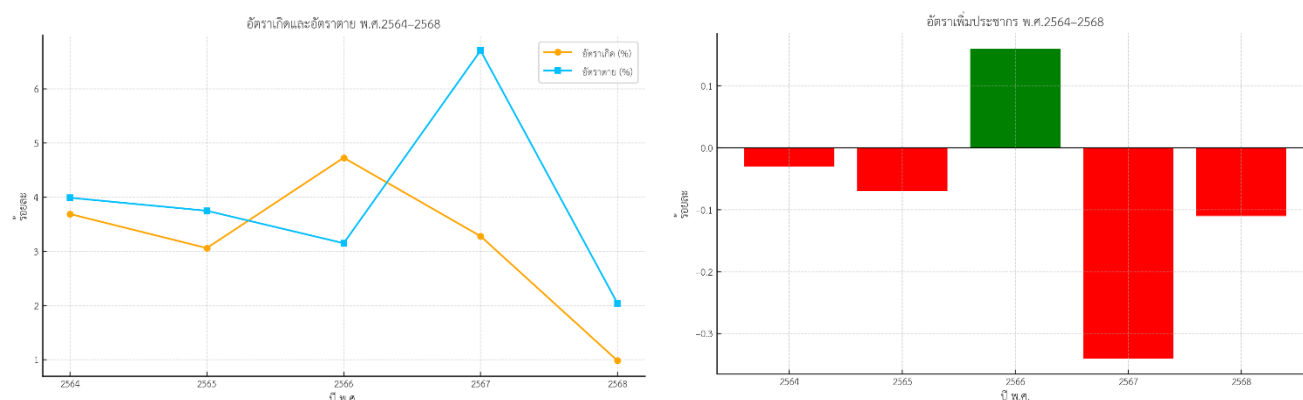
ตาราง 10 แสดงจำนวนเกิด-ตาย ร้อยละการเพิ่มประชากรและประชากรกลางปี ปี พ.ศ.2564-2568

ปี พ.ศ.	จำนวนเกิด	จำนวนตาย	อัตราเกิด**	อัตราตาย**	อัตราเพิ่มประชากร***	ประชากร 1 ม.ค.
ปี 2564	48	52	3.69	3.99	-0.03	13,022
ปี 2565	40	49	3.06	3.75	-0.07	13,058
ปี 2566	63	42	4.73	3.15	0.16	13,328
ปี 2567	43	88	3.28	6.71	-0.34	13,106
ปี 2568	13	27	0.98	2.04	-0.11	13,243

ที่มา: ฐานข้อมูลเกิด-ตาย(ปีที่เกิด-ตายตามทะเบียน) JHCIS ศบส.บ้านโทกหัวช้าง ณ วันที่ 30 ก.ย.68

หมายเหตุ: หน่วยแสดง ** อัตราต่อพันประชากร *** อัตราร้อยละ

รูปภาพ 3 แสดงกราฟอัตราการเกิด-ตาย และอัตราเพิ่มประชากร ปี 2564-2568



จากรูปภาพ 3 แสดงอัตราเกิด-ตาย จากกราฟแสดงให้เห็นแนวโน้มอัตราเกิดและอัตราตายในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้างพบว่าอัตราเกิดมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากปี 2564 ถึง 2568 โดยในปี 2566 เป็นปีเดียวที่อัตราเกิดสูงกว่าอัตราตายส่วนปี 2567 พบว่าอัตราตายสูงสุดถึง 6.71% ซึ่งสูงกว่าอัตราเกิดถึงสองเท่าสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่มีภาวะการเกิดน้อยลงและการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในส่วนอัตราเพิ่มประชากร พ.ศ. 2564-2568 กราฟแสดงอัตราการเพิ่มของประชากรในพื้นที่ พบว่ามีค่าติดลบเกือบทุกปีโดยมีเพียงปี 2566 ที่อัตราเพิ่มประชากรเป็นบวก (+0.16%) จากการที่อัตราเกิดสูงกว่าอัตราตายส่วนปี 2567 มีอัตราลดลงมากที่สุด (-0.34%) ภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่าจำนวนประชากรมีแนวโน้มคงที่หรือลดลง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ตาราง 11 แสดงสาเหตุการตาย 10 ลำดับ ปีงบประมาณ 2566-2568 (อัตราต่อแสนประชากร)

ที่	สาเหตุการตาย	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	มะเร็งทุกชนิด	3	22.51	10	76.30	12	90.61
2	โลหิตเป็นพิษ	4	30.01	13	99.19	9	67.96
3	โรคหัวใจ	7	52.52	2	15.26	4	30.20
4	เลือดออกในสมอง	4	30.01	4	30.52	4	30.20
5	ไตวาย	2	15.01	2	15.26	4	30.20
6	ฆ่าตัวตาย	1	7.50	1	7.63	2	15.10
7	หลอดเลือดสมอง	0	0.00	2	15.26	1	7.55
8	ถุงลม	1	7.50	1	7.63	1	7.55
9	วัณโรค	2	15.01	0	0.00	1	7.55
10	โรคตับ	0	0.00	1	7.63	1	7.55

ที่มา: รายงานการเสียชีวิต ฐานข้อมูล JHCIS ศบส.บ้านโทกหัวช้าง ณ วันที่ 30 ก.ย.2568

จากตารางที่ 11 แนวโน้มสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในเขตรับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้างในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจาก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 พบผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวมากที่สุด รองลงมาคือโรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งทุกชนิด สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพเรื้อรังในกลุ่มวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุ ปี 2567 จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยมี มะเร็งทุกชนิดเป็นสาเหตุหลัก รองลงมาคือโรคไตวายและโรคหลอดเลือดสมอง แสดงให้เห็นว่าภาวะโรคเรื้อรังยังคงเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ ส่วนปี 2568 แม้จำนวนผู้เสียชีวิตโดยรวมลดลงจากปีก่อน แต่ยังคงพบสาเหตุหลักเป็น โรคโลหิตเป็นพิษ มะเร็งทุกชนิด และโรคหัวใจล้มเหลว ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรังและการติดเชื้อในผู้สูงอายุ โดยสรุป แนวโน้มการเสียชีวิตในพื้นที่ยังคงเน้นหนักไปที่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพและโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้างจึงควรมุ่งเน้นมาตรการ ส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุ และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตในระยะยาว

3.2 ข้อมูลการเจ็บป่วย

ตาราง 12 แสดง 10 ลำดับโรคแยกตาม ICD10 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	โรค	จำนวนคน	จำนวนครั้ง
1	ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)	328	1628
2	เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	205	1075
3	เวียนศีรษะ	259	371
4	คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด)	272	367
5	ปวดกล้ามเนื้อ แขนท่อนปลาย	177	294
6	โรคการไหลย้อน	82	166
7	ฟันผุที่จำกัดเฉพาะเคลือบฟัน	136	136
8	ภาวะไขมันในเลือดสูงเกิน ไม่ระบุรายละเอียด	61	136
9	โรคจิตที่ไม่ระบุรายละเอียด	15	99
10	แผลเปิดที่เข้า	86	90

ที่มา: ฐานข้อมูล JHCIS ศบส.บ้านโทกหัวช้าง ณ วันที่ 30 ก.ย.2568

จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยนอกของศูนย์บริการสาธารณสุขสุขบ้านโทกหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า โรคที่พบบ่อยที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) มีผู้มารับบริการจำนวน 328 คน รวม 1,628 ครั้ง รองลงมาคือ โรคเบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด มีผู้มารับบริการ 205 คน รวม 1,075 ครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ยังคงเป็นภาระทางสุขภาพหลักของประชาชนในพื้นที่ และจำเป็นต้องได้รับการติดตามต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังพบโรคทั่วไปที่เกิดจากพฤติกรรม การดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น อาการเวียนศีรษะ จำนวน 259 คน, คอหอยอักเสบจากการติดเชื้อ จำนวน 272 คน และ อาการปวดหลังส่วนล่าง จำนวน 82 คน ซึ่งมักเป็นโรคเฉียบพลันที่พบได้บ่อยในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ สำหรับ โรคในช่องปาก เช่น ฟันผุและเหงือกอักเสบ พบผู้มารับบริการ 136 คน รวม 166 ครั้ง แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริการทันตกรรมในระดับชุมชนที่ยังคงมีความสำคัญ ขณะเดียวกันยังพบ ปัญหาทางเดินอาหาร เช่น โรคกรดไหลย้อน และ ภาวะการย่อยอาหารผิดปกติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การรับประทานอาหารและความเครียดในชีวิตประจำวัน ในส่วนของ การบาดเจ็บและอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น แผลเปิดบริเวณเท้า พบผู้ป่วย 86 คน รวม 90 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อน โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ควบคู่กับโรคทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน

ตาราง 13 แสดงโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ 10 อันดับ ในปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	โรค	จำนวน	อัตราป่วย
1	โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)	34	256.74
2	โรคไข้เลือดออก (Dengue fever; DF)	31	234.09
3	โรคเยื่อบุตาอักเสบ (Conjunctivitis, unspecified)	6	45.31
4	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	4	30.20
5	โรคติดเชื้ออาร์เอสวี RSV (Respiratory Syncytial Virus)	4	30.20
6	ไข้ดำสีแดง (Scarlet Fever)	3	22.65
7	โรคอีสุกอีใส (chicken pox)	2	15.10
8	โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (chikungunya virus disease)	2	15.10
9	ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A	2	15.10
10	โรคไขหูดับ (Streptococcus suis)	2	15.10

ที่มา: ข้อมูลจากฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคระบาด ข้อมูลถึง วันที่ 30 ก.ย.2568 (อัตราป่วย หน่วยต่อแสนประชากร)

จากตารางแสดงข้อมูล 10 อันดับโรคติดต่อที่สำคัญทางระบาดวิทยา ของศูนย์บริการสาธารณสุขสุขบ้าน โทกหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า โรคที่มีการรายงานมากที่สุดคือ โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) จำนวน 34 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 256.74 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ โรคไข้เลือดออก (Dengue fever) จำนวน 31 ราย อัตราป่วย 234.09 ต่อแสนประชากร ซึ่งทั้งสองโรคเป็นโรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและสัมพันธ์กับฤดูกาล ในลำดับที่ 3 พบ โรคเยื่อบุตาอักเสบ (Conjunctivitis) จำนวน 6 ราย และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 30.20 ต่อแสนประชากร ซึ่งแม้จำนวนผู้ป่วยลดลงมากจากช่วงการระบาดใหญ่ แต่ยังคงพบประปรายในชุมชน ส่วนโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจในเด็ก ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัส RSV อยู่ในลำดับที่ 5 จำนวน 4 ราย เช่นเดียวกับโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่พบเป็นจำนวนน้อย เช่น โรคมือเท้าปาก, โรคอีสุกอีใส, โรคไข้ปวดข้อยุงลาย, โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส, และ โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนชนิด A ซึ่งแต่ละโรคมีจำนวนผู้ป่วยเท่ากันคือ 2 ราย (อัตราป่วย 15.10 ต่อแสนประชากร)

ตาราง 14 แสดงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 10 อันดับ ในปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	โรค	จำนวน	อัตราป่วย
1	โรคความดันโลหิตสูง	1,997	15079.66
2	โรคเบาหวาน	926	6992.37
3	โรคไตเรื้อรัง	218	1646.15
4	โรคหลอดเลือดสมอง	120	906.14
5	โรคหอบหืด	63	475.72
6	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	19	143.47
7	โรคมะเร็งเต้านม	11	83.06
8	โรคมะเร็งปากมดลูก	4	30.20
9	โรคหัวใจขาดเลือด	3	22.65
10	โรคมะเร็งมะเร็งลำไส้	1	7.55

ที่มา: ฐานข้อมูล JHCIS ศบส.บ้านโทกหัวช้าง ณ วันที่ 30 ก.ย.2568 (อัตราป่วย หน่วยต่อแสนประชากร)

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า โรคที่พบมากที่สุดในพื้นที่คือ โรคความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วยจำนวน 1,997 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15,079.66 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ โรคเบาหวาน จำนวน 926 ราย อัตราป่วย 6,992.37 ต่อแสนประชากร ซึ่งทั้งสองโรคนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญและมักพบร่วมกันในกลุ่มประชากรวัยกลางคนและผู้สูงอายุ โรคที่พบในลำดับต่อมา ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง จำนวน 218 ราย และ โรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 120 ราย ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดตามมาจากการควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตไม่ดีพอ นอกจากนี้ยังพบโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกาดำเนินชีวิต เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจขาดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งแม้จำนวนผู้ป่วยจะไม่มาก แต่เป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง